



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض ربيعاً : شريف محمد احمد السيد
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : الشروق
رقم البطاقة : 28111070102333 رقم التليفون : 01002244690
العمر (تاريخ الميلاد) : 07-11-1981 المهنة : ربه منزل
العنوان : -
تاريخ تسجيل الإستمارة : 26-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل :- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الأبحاث و الاشعات [7954] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

د. / ----- د. / ----- د. / -----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: شريف محمد احمد السيد National ID: 28111070102333	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Further investigations and imaging

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين

جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية



شريف
محمد احمد السيد منصور
ق ٤٠ مج ٢ م ١ عمارات
السروق - القاهرة

٢٨١١١٠٧٠١٠٢٣٣٣

JM1891172

٢٠٢٢/٠٨ ٢٨١١١٠٧٠١٠٢٣٣٣

صاحب مكتب سماعات سماعات
التجار الخفيف والأنظمة الأمنية
متروج مسلم نكر

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٨/٠٨





Ministry of Health and Family Welfare
Government of Punjab, Pakistan

وزارة الصحة والعائلة
الحكومة Punjab



A-Patient ID

1- Name

فريال محمد شمس الدين

Sex:

MDT form

2- Medical number

Date

03257707

01/06/21

Page No.

308-3025

3- ID number

Patient Age: 43 Y



Family history

None

Phone

PNF

03000070453

BMI

24

Marital status

Married

NAS Score

0/24

GROUP

Group

REASON OF MDT

Metastatic disease

Co-morbidities

DM

Menopausal status

Postmenopausal

Initial stage

Stage

Date of MDT

2021-02-07

Breast Imaging:

Clinical data

Mets Workup:

pet ct: 16 breast retroareolar metabolically active malignant neoplastic mass

BX IDC	ER 8/8	PR 8/8	HER 2 Neu 1	SISH	Ki67 10
ER-Positive	ER-Positive	PR-Positive	HER 2 Neu Negative	SISH Positive	Ki67 Positive

T 1	N 0	M 0
--------	--------	--------

Sonamammography

PATIENT HISTORY

1t SM+SLNB: IDC pt1 1 cm
free resected margin
free LN 0/3

MDT OUTCOME & PLAN

adjuvant tam x5 years

MEDICAL ONCOLOGY

SIGNATURE

RADIOLOGY

SURGERY

PATHOLOGY

Psychiatric

Nutrition

Dr.
Elia Anis Ishak

M. Sc. Ph. D. Pathology - Prof. of Pathology, Cairo University
Fellow, Armed Forces Institute of Pathology, USA
Member, United States Canadian Academy of Pathology

Dr.
Shady Elia Anis

M. Sc. MD Pathology, Ass. Prof. of Pathology, Cairo University
Fellow, Mass General Hospital, Harvard, USA
Member, United States Canadian Academy of Pathology

Patient Name : شريف محمد احمد السيد

Age : 43 Y : 2 M : 8 D

Referred By Prof. Dr. : مصطفى عروة

Clinical Diagnosis : Left breast lesion

Nature of Specimen : Core needle biopsy

Receiving Date : 2025-01-16

Analysis ID : 023775

Gender : Male

Patient ID : 688914

PATHOLOGY REPORT

Gross :

Fragmented grayish white tissue cores, the longest measured 1 cm, totally submitted.

Microscopic :

Serial sections examined from the specimen received revealed cores of tumour tissue formed of malignant ductal epithelial cells, showing moderate nuclear pleomorphism and hyperchromasia. There is poor attempt at tubular formation.

There are moderate number of mitotic figures.

There is marked desmoplasia.

There is peritumoural lymphocytic infiltrate around 5 %.

No necrosis.

No intraductal component

Diagnosis :

Left breast lesion, Core needle biopsy, INFILTRATING DUCT CARCINOMA, GRADE II.

Prof. Dr. Shady Elia Anis

Prof. Dr. Elia Anis Ishak

Shady Elia Anis

Elia Anis



This report is electronically signed, any alteration or modification would render it void

1/1

عمارة رمسيس - بابوك أ - ميدان رمسيس - الدور السادس و السابع
تيلفون : ٢٥٧٧٢١٥٢ - ٢٥٧٧٢١٥٣ - ٢٥٧٩٠٩٣٥ - ٢٥٩١٧٠٠٠١٢٨٧

Dr.
Elia Anis Ishak

M. Sc. Ph. D. Pathology - Prof. of Pathology, Cairo University
Fellow, Armed Forces Institute of Pathology, USA
Member, United States Canadian Academy of Pathology

Dr.
Shady Ella Anis

M. Sc. MD Pathology, Ass. Prof. of Pathology, Cairo University
Fellow, Mass General Hospital, Harvard, USA
Member, United States Canadian Academy of Pathology

Patient Name : شريف محمد احمد السيد

Age : 43 Y : 2 M : 1 D

Referred By Prof. Dr. : حسان الشاهر

Clinical Diagnosis : Left breast lesion

Nature of Specimen : Block (Labelled as 923775)

Receiving Date : 2026-01-22

Analysis ID : 925274

Gender : Male

Patient ID : 688914

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Technique :

Sections were prepared from the paraffin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain.

The sections were treated against:

- Estrogen receptors - Progesterone receptors - Her 2 - Ki67.

Results :

90% of tumor cells show strong POSITIVE Staining for Estrogen receptors.

90% of tumor cells show strong POSITIVE Staining for progesterone receptors.

Sections treated for HER2 revealed MODERATE CONTINUOUS CELL MEMBRANE STAINING IN MORE THAN 10% OF TUMOR CELLS.

15% of Tumour cells are POSITIVE for Ki67.

Conclusion :

Block, TUMOUR CELLS ARE;

POSITIVE FOR ESTROGEN RECEPTORS (SCORE 8 / 8).

POSITIVE FOR PROGESTERONE RECEPTORS (SCORE 8 / 8).

→ HER 2 EQUIVOCAL, SCORE 2+.

- CASE FOR CONFIRMATION OF HER 2 GENE AMPLIFICATION BY SISH TECHNIQUE.
THE PROLIFERATION INDEX OF Ki67 IS 15%.

Prof. Dr. Shady Ella Anis

Prof. Dr. Elia Anis Ishak

Shady Ella Anis

Elia Anis



This report is electronically signed, any alteration or modification would render it void.

1/1

عمارة رمسيس - بلوك أ - ميدان رمسيس - الدور السادس و السابع
تليفون : ٢٥٧٧٣١٥٢ - ٢٥٧٧٣١٥٣ - ٢٥٧٧٣١٥٤ - ٢٥٧٧٣١٥٥

Patient Name	: الأستاذة / شروق محمد احمد السيد منصور	Request No.	: 13008069
Patient No.	: 128111070102333	Request Date	: 30/01/2025
Path No.	: SR-166/25	Verification Date	: 30/01/2025
Sex	: Female	Financial Category	: برنامج دار السلام - نفقة الدولة
Age	: 43 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: Mrs. Mayada Hegazy

Pathology Report

Clinical Data

Left breast mass

Nature of specimen

Slide revision

Gross examination

5 slides labelled by (688914) were received

IHC technique: Sections prepared from paraffin block for Immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR, HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination

- * Histological type: Invasive duct carcinoma
- * Grade (differentiation + nuclear pleomorphism + mitosis): (3+2+2) Grade II
- * DCIS: No
- * Angiolinvasion: Positive
- * Perineural invasion: Positive
- * Additional pathological findings : lymphocytic infiltrate 5 %
- * IPT (Positive control showed appropriate reactivity) :
- * ER: Strong nuclear reaction in 80 % tumor cells (Allred score 8/8)
- * PR: Strong nuclear reaction in 70 % tumor cells (Allred score 8/8)
- * HER2: aint incomplete membrane reaction in <10% of tumor cells (score 1+)
- * Ki 67: 10 % nuclear reaction of tumor cells

Diagnosis

Verified by :

Dr. Heba Hasan

Printing Date : 03/02/2025 14:36:31

Page 1 of 2

Printing By : thermal

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - معمل الباثولوجية - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Mkr El Qadema - Cairo, Egypt

Patient Name : الأمثلة / شريف محمد أحمد السيد منصور
 Patient No. : 28111070102333
 Path No. : SR-166/25
 Sex : Female
 Age : 43 Y
 Referring Doc :

Request No. : 13008069
 Request Date : 30/01/2025
 Verification Date : 30/01/2025
 Financial Category : أورام دار السلام - بقعة الدولة
 Department : Out Patient
 Registered by : Mrs. Mayada Hegazy

Pathology Report

Left breast mass, Tru cut biopsy:
 Invasive duct carcinoma, Grade II
 IPT:

- * ER: Positive (score 8/8).
- * PR: Positive (score 8/8).
- * HER2: (score 1+).
- * Ki67: Positive in 10% of tumor cells.

Signature
 Dr. Salma Tarek
 Dr. Heba Hassan

Verified by :
 Dr. Heba Hasan

Printing Date : 03.03/2025 14:36:31

Page 2 of 2

Printing By : harnal

Patient Name : الأيكة / شريف محمد أحمد السيد منصور	Request No. : 13003387
Patient No. : 28111070102333	Request Date : 18/02/2025
Path No. : 714/25	Verification Date : 03/03/2025
Sex : Male	Financial Category : فئة الدولة - اورام داء السلام
Age : 43 Y	Department : Out Patient
Referring Doc :	Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Left breast cancer, Up-Front.

Nature Specimen: Left simple mastectomy and SLNs.

Gross Examination:

- * Procedure: Left simple mastectomy specimen measured 16x15x3 cm with covering skin ellipse measured 16x5.7 cm.
- * Tumor extent: A greyish white firm mass.
- * Localization: retroareolar.
- * Size: 1x0.6x0.07 cm.
- * Skin involvement: The nipple was fixed.
- * Distance from margins: 2.5 cm away from deep margin and 0.1 cm away from the skin of the nipple.
- * Lymph nodes number and size: Fibrofatty tissue piece measured 3.5x3 cm, entangling 3 lymph nodes, up to 2x1.5.

* Frozen section results:

Free SLNs: (0/3)

* Designation:

- 1-2- The nipple, areola and the mass.
- 3- The deep margin.
- 4- Rest of cul section.
- 5- The SLNs.

* Dissected by: Dr.Toka Medhat,

Microscopic Examination:

- * Histological type: Invasive duct carcinoma.

Verified by :

Dr.Toka Medhat

Printing Date : 03/03/2025 10:14:26

Page 1 of 2

Printing By : Mrs.Mayada Hagazy



غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر الجديدة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Nive ElQadima - Cairo, Egypt



Patient Name	: الاستاذ / شريف محمد أحمد السيد منصور	Request No.	: 13003387
Patient No.	: 28111070102333	Request Date	: 18/02/2025
Path No.	: 714/25	Verification Date	: 03/03/2025
Sex	: Male	Financial Category	: أورام بار السن - نفقة الدولة
Age	: 43 Y	Department	: Out Patient
Referring Doc :		Registered by	: marwa mohamed youss

Pathology Report

- * Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism+ mitosis): Grade II (3+2+1).
- * Angiolinvasion: Negative.
- * Perineural Invasion: Positive.
- * Ductal carcinoma in situ: Positive.
- * Skin Involvement: Infiltrated dermis by the tumor, but free epidermis.
- * Lymph node Involvement: Free SLNs (0/3).
- * Resection Margins: Free deep resection margin.
- * Microcalcifications: Negative.

Diagnosis:

Left breast, simple mastectomy and SLNs Biopsy:

- Invasive duct carcinoma.
- Free deep resection margin.
- Infiltrated dermis by the tumor, but free epidermis.
- Free lymph nodes: (0/3).
- Stage: pT1b, pN0.

Signature

Prof. Dr. Gamal Abdelaaty.
Dr. Toka Medhat.

Verified by :

Dr.Toka Medhat

Printing Date : 03/03/2025 10:14:26

Page 2 of 2

Printing By : Mrs.Mayada Hegazy



NAME: SHEREEF MOHAMED AHMED
AGE : 43 Y
DATE : 23 December 2024

BREAST (M) U/S REVEALED

- 1. Presence of ill defined hard soft tissue swelling at subcutaneous area of LT. breast areola , of 4x7 mm (approximately) of hyperechoic homogenous echogenicity , small macro-calcification seen inside , retracted nipple on top with no pain over .
- 1. Normal skin of LT. & RT. breast regions
- 1. Normal deep subcutaneous area of both sides of breast with no glandular components inside
- 1. Normal axillary area with no lymphadenopathy seen bilaterally.

Conclusion:

.. LT. breast subcutaneous hard focal lesion for further evaluation.

Much obliged
Dr. SAMEH SHEHAB, MD
Radiology consultant

Clinical summary:

CORE NEEDLE BIOPSY (CNB) REPORT

*For your kind care,
Histopathology,*

*Breast Imaging Consultant
& Breast Intervention*

 Hotline
19989
www.technicianonline.com

[illegible]